EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67757
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-20 13:04:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS RENATO PE►A MORALES			RUN	: 2.882.974-4
F.Nac	: 20-07-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 20-07-2023	Fecha Egreso	: 2023-07-20 13:04:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Sd confusional agudo
-Neumonía postero-basal derecha
-B12 límite

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
-Enf: HTA, temblor esencial, deterioro cognitivo tipo EA (3 años evolución, dependencia moderada), trast sueño, hipoacusia moderada
-Fcos: LST 50 mg c/12h, PPN 40 mg/d, CNZ 0.5 mg/n (usa 1/2 comp)
-Alergia(-)
-Qx: apendicectomía
-OH(-) Tabaco(-) Alergia(-)
-mRS 3

Historia clínica
Paciente previamente en su basal, comenzó el 18/7 con agitación y confusión nocturna, el 21/7 se observó con leve bradipsiquia, tos productiva y fiebre (aprox 38° C); ese mismo día, posterior a siesta, despierta aprox a las 17.00h con disartria marcada e inestabilidad de la marcha. Consultó en SU HSC, TC cerebro s/c mostró lesión de specto isquémico crónico/secuelar temporal izquierdo, sin lesiones agudas, angioTC cerebro y cuello sin lesiones arteriales o venosas, no se observaron nuevas lesiones en parénquima cerebral. Se ingresó para estudio y manejo.

Evolución
Paciente se mantiene en BEG, HDN estable, con regresión espontánea y casi completa de disartria y de alteración de la marcha, mantiene leve confusión, no refiere molestias, RS al monitor, eupneico, afebril, sin aumento del trabajo ventilatorio, tos productiva ocasional.
TC cerebro s/c de control no mostró lesiones agudas nuevas, TC torax s/c mostró neumonía postero-basal derecha y hernia hiatal.
Se retiró SNG, tolera bien alimentación papilla, marcha estable con uso parcial de andador.
Exs de lab destaca aumento leve de PCR y HB, fx renal con leve deterioro.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy y continuar manejo ATB EV por HODOM.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-IC a HODOM para continuar tto ATB
-No usar CNZ
-Reiniciar resto de tto crónico
-ETT y Holter ritmo

INDICACIONES AL ALTA

1. -Ceftriaxona 2g/d EV por 7 días
2. -Ipratropio 2 puff c/6 horas

EXÁMENES Y RESULTADOS

20/7/23
-Alb 3.7
-Crea 1.2 MDRD 56.63 Uremia 43
-AU 6
-Ca 8.8 P 3.5 Na 137 K 3.9 CL 104
-BI 2.7 BD 0.08 BT 2.78 GOT 30 GPT 21 GGT 51
-CKMB 3 CK 107
-LDH 146
-Lact 1.8
-PCR 82.8
-Leu 12300 Hb 13.3 Plaq 134000 Seg 82 VHS 14
-TSH 4.3 T4L 1.17
-B12 169 Vit D 24.9 Folato 19.5
-Procal 10.61 (artefactual?)
-GSA pH 7.45 CO2 36 HCO3 25
-Hb glic 5.2
-RPR N/R

19/7/23
-Glic 116
-Crea 1.2 MDRD 56.63 Uremia
-FA 123 BI 2.37 BD 0.03 BT 2.4 GOT 35 GPT 21 GGT 56
-CKMB 7 CK 73
-Lact 1.3
-PCR 28.4
-Na 137 K 3.7 Cl 103
-Hb 13.8 Leu 10500 Plaq 131000 Seg 90
-INR 1.11 TTPA 26
-Trop 10.2

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) estertores escasos bilaterales, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurologico:
-Mental: vigil, parcialmente OTE, confuso, lenguaje fluente con parafasias verbales y dificultades para nominación (es basal), repetición N, distingue derecha-izquierda cruzando linea media
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, fascie impresiona simétrica, sensibilidad facial impresiona N, pares bajos impresionan N
-Motor: M5 en las 4 EE, RCP flexor bilateral
-Sensitivo: impresiona conservado
-Cerebelo: impresiona conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO